

Prévalence des anomalies du bilan hépatique chez les patients obèses et leur association avec les paramètres anthropomorphiques : étude observationnelle rétrospective

A. DAHMANI¹

¹Laboratoire de Physiologie/CHU Blida

Introduction

La stéatose hépatique associée aux dysfonctions métaboliques (MASLD) représente l'une des complications les plus fréquentes de l'obésité. Les perturbations du bilan hépatique constituent des biomarqueurs biologiques accessibles permettant un dépistage précoce des atteintes hépatiques. L'objectif de cette étude était d'évaluer la prévalence des anomalies du bilan hépatique chez les patients obèses et d'analyser leur relation avec les paramètres anthropométriques.

Matériels et méthodes

Une étude observationnelle rétrospective a été réalisée chez **81 patients obèses** (IMC ≥ 30 kg/m²) ayant bénéficié d'une évaluation nutritionnelle et métabolique. Les données recueillies comprenaient l'âge, le sexe, l'IMC, le tour de taille, les taux d'ALAT, d'ASAT, de GGT ainsi que les paramètres glycémiques et lipidiques. Les analyses statistiques ont recherché les facteurs associés aux anomalies biologiques hépatiques.

Résultats

L'âge moyen des patients était de **45,9 $\pm$ 10,8 ans**, avec une prédominance féminine (**70,4 %**). Une élévation d'au moins une enzyme hépatique a été observée chez **38,3 %** des patients. Les sujets présentant une cytololyse avaient un IMC significativement plus élevé (**36,8 $\pm$ 4,9 vs 33,7 $\pm$ 4,2 kg/m² ; **p = 0,01**) ainsi qu'un tour de taille plus important (**p = 0,02**). Les concentrations d'ALAT étaient positivement corrélées aux triglycérides (**r = 0,42 ; p = 0,004**) et à la glycémie à jeun (**r = 0,35 ; p = 0,01**).**

Conclusion

Les anomalies du bilan hépatique sont fréquentes chez les patients obèses et sont étroitement associées aux marqueurs de risque cardiométabolique.

Le dosage systématique des enzymes hépatiques, intégré à une évaluation fonctionnelle métabolique, constitue une approche simple et pertinente pour le dépistage précoce de la MASLD et l'orientation d'une prise en charge nutritionnelle adaptée.

Mots-clés :

Métabolisme énergétique de repos, calorimétrie indirecte, dyslipidémie, surcharge pondérale, risque cardiométabolique